

Protocolo de alta — Herniorrafia inguinal con malla

Servicio de Cirugía General. Seguimiento telefónico del paciente operado de hernia inguinal con colocación de malla de polipropileno, con alta el mismo día.

Cuidado de la herida

La incisión va en el pliegue de la ingle y mide entre cinco y ocho centímetros. Manténgala limpia y seca cuarenta y ocho horas; después puede ducharse a diario, secando la zona con cuidado y sin frotar. No sumerja la herida en bañeras ni piscinas hasta la revisión.

Es normal que aparezcan hematoma e hinchazón en la ingle, y que bajen hacia el escroto o el labio mayor por gravedad durante la primera semana. Cambian de color del morado al verde y al amarillo antes de desaparecer, y pueden tardar de dos a tres semanas. Un suspensorio o ropa interior ajustada alivia la molestia.

Notará un bulto duro bajo la cicatriz durante varias semanas: es la reacción del tejido a la malla, no una recidiva de la hernia. Se ablanda solo.

Medicación

El dolor de este posoperatorio es moderado y se controla bien con analgésicos simples. La malla no requiere antibiótico al alta.

Medicamento	Dosis	Pauta	Duración	Observaciones
Acetaminofén	500 mg	cada 6 horas	5 días	No superar 4 g en 24 horas
Ibuprofeno	400 mg	cada 8 horas	si dolor	Con alimentos, máximo 5 días

Tome el analgésico a horas fijas los dos primeros días en lugar de esperar a que aparezca el dolor: cuesta menos controlarlo que recuperarlo una vez instaurado.

Signos de alarma

Acuda a urgencias si presenta fiebre superior a 38.5 grados, enrojecimiento caliente que se extiende alrededor de la incisión, salida de pus por la herida, dolor inguinal intenso y creciente que no cede con la analgesia pautaada, imposibilidad de orinar durante más de ocho horas, o aparición de un bulto doloroso, duro e irreducible en la ingle acompañado de náuseas y vómitos.

Ese último cuadro sugiere una hernia atascada y es la urgencia quirúrgica de este posoperatorio: no espere a la cita de control ni a la llamada de seguimiento.

Retención urinaria

No orinar en ocho horas es motivo de consulta inmediata.

Actividad

Levántese y camine el mismo día de la operación. La deambulación precoz es lo que más reduce el riesgo

de trombosis y de retención urinaria.

Evite levantar más de cinco kilos durante dos semanas y no supere los diez kilos hasta el mes. Toser y estornudar sujetando la ingle con la mano abierta reduce mucho la molestia. Puede reanudar las relaciones sexuales cuando resulten cómodas, en general a partir de la segunda semana. El deporte de impacto y el levantamiento de pesas se reanudan a las cuatro o seis semanas, y siempre de forma progresiva.

Conducir es seguro cuando pueda frenar de golpe y girar el tronco sin dolor, habitualmente entre el quinto y el séptimo día.

Dieta

No hay restricciones dietéticas después de una herniorrafia: puede volver a su alimentación habitual desde el mismo día.

Lo único que sí importa es evitar el estreñimiento, porque hacer fuerza en el baño somete la reparación a la misma presión que levantar peso. Beba al menos dos litros de agua al día, incluya fruta, verdura y cereales integrales, y si al tercer día no ha tenido deposición pida un laxante suave en la llamada de seguimiento antes de forzar.

Cita de control

La revisión de la malla y de la cicatriz se programa a los nueve días en el consultorio indicado en su hoja de alta.